Estilo UERJ

Simulado R04 Caderno

Simulado de revisão no formato da UERJ, montado a partir dos seus erros nos Simulados 1 a 4: quatro alternativas e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

26 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Mulher de 29 anos, sem comorbidades, em uso de anticoncepcional oral, apresentou há 4 dias cefaleia, febre baixa, petéquias e dois episódios de afasia transitória. No hospital de origem: Hb 7,0 g/dL, plaquetas 8.000/mm³, esquizócitos 7%, LDH 1.480 U/L, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo, creatinina 1,3 mg/dL, TP e fibrinogênio normais. Recebeu metilprednisolona e duas sessões de plasmaférese antes da transferência, sem amostra guardada. Na chegada: PA 152 × 94 mmHg, Glasgow 15, sem déficit focal, plaquetas 19.000/mm³, LDH 1.120 U/L, creatinina 1,2 mg/dL, sem diarreia nas últimas semanas e pesquisa de toxina Shiga negativa. A atividade de ADAMTS13, colhida no novo hospital após a segunda sessão de plasmaférese, é de 46%. O nefrologista sugere suspender a plasmaférese e iniciar eculizumabe pela pressão alta. A conduta mais adequada é:

A) Manter plasmaférese diária e corticoide

B) Suspender a plasmaférese e iniciar eculizumabe

C) Suspender a plasmaférese e transfundir plaquetas

D) Suspender a plasmaférese e iniciar hemodiálise

---

2 Mulher de 48 anos, assintomática, faz ultrassonografia de tireoide solicitada em check-up depois que a irmã teve carcinoma papilífero aos 52 anos. Nega irradiação cervical na infância e outros casos de câncer de tireoide na família. Exame cervical sem nódulos ou linfonodos palpáveis. TSH 1,9 mUI/L. A ultrassonografia mostra nódulo único no lobo direito, de 1,2 × 1,0 x 0,9 cm, sólido, isoecoico, mais largo que alto, de margens lisas, sem focos ecogênicos, e nenhum linfonodo cervical suspeito. Por iniciativa própria, um clínico já havia dosado a tireoglobulina sérica: 96 ng/mL (até 55). A paciente está ansiosa e pede que o nódulo seja retirado. A conduta mais adequada é:

A) Cintilografia de tireoide com iodo-123

B) Seguimento ultrassonográfico, sem punção

C) Punção aspirativa com agulha fina

D) Lobectomia diagnóstica direita

---

3 Homem de 34 anos procura o pronto-socorro com 4 dias de parestesias nos pés e nas mãos e fraqueza ascendente; hoje precisa de apoio para andar 5 metros. Teve diarreia há 2 semanas, resolvida sem tratamento. Sem febre, sem alteração esfincteriana, sem nível sensitivo. FC 112 bpm, PA oscilando entre 168/98 e 104/60 mmHg, FR 18 irpm, SpO2 97% em ar ambiente. Força grau 3 em membros inferiores e grau 4 em superiores, proximal e distal, arreflexia global, vibração reduzida nos pés. Capacidade vital forçada de 32 mL/kg. Líquor no 4º dia: 3 células/mm³, proteína 41 mg/dL (referência até 45), glicose normal. Eletroneuromiografia: ondas F com latência prolongada, velocidades de condução motora ainda normais. A conduta mais adequada é:

A) Repetir líquor e ENMG em 7 dias

B) Metilprednisolona IV em pulso

C) Imunoglobulina IV, 2 g/kg em 5 dias

D) Intubação orotraqueal eletiva agora

---

4 Homem de 59 anos, com carcinoma epidermoide de orofaringe recidivado e metástases ósseas, em cuidados paliativos domiciliares, vinha usando morfina de liberação imediata 20 mg por via oral de 4 em 4 horas, com dor controlada (2 em 10) e no máximo um resgate por dia nas últimas 2 semanas. Desde ontem, com piora da mucosite e da massa cervical, não consegue engolir nem líquidos e perdeu as três últimas doses. Chega à emergência com dor 8 em 10, inquieto, lúcido. PA 150/90 mmHg, FC 108 bpm, FR 20 irpm, SatO2 96%, mucosas pouco secas. Creatinina 0,8 mg/dL, sódio 141 mEq/L. A família traz um adesivo de fentanil 50 mcg/h prescrito por outro serviço, ainda não usado, e há acesso subcutâneo disponível. A conduta analgésica de manutenção mais adequada neste momento é:

A) Fentanil transdérmico 50 mcg/h isoladamente

B) Morfina 20 mg subcutânea de 4 em 4 horas

C) Tramadol 100 mg intravenoso de 6 em 6 horas

D) Morfina 10 mg subcutânea de 4 em 4 horas

---

5 Homem de 66 anos, tabagista de 50 maços-ano, apresenta edema de membros inferiores há 2 meses. É hipertenso controlado com hidroclorotiazida e perdeu 4 kg no período, que atribui à dieta. PA 134 × 82 mmHg, edema 3+/4+ até a raiz das coxas. Albumina 2,1 g/dL, colesterol total 340 mg/dL, proteinúria de 24 horas de 7,8 g, creatinina 1,1 mg/dL, sedimento sem hematúria dismórfica. FAN, anti-HCV, HBsAg e VDRL negativos; C3 e C4 normais; eletroforese e imunofixação de proteínas sem componente monoclonal. Anti-PLA2R sérico negativo. Biópsia renal: espessamento difuso da membrana basal com espículas e depósitos subepiteliais granulares de IgG, com predomínio de IgG1 e IgG2, IgG4 fraca, PLA2R negativo no tecido e mais de 8 células inflamatórias por glomérulo. O laudo conclui por nefropatia membranosa. O próximo passo mais adequado é:

A) Novo anti-PLA2R sérico em 6 meses

B) Rastreio de neoplasia com TC de tórax

C) Ciclosporina com corticoide em dose baixa

D) Rituximabe com bloqueio do SRAA

---

6 Mulher de 27 anos, com asma desde a infância e rinite alérgica, está sem tratamento de manutenção há 3 anos e usa salbutamol spray quase todos os dias. Refere sintomas diários e despertares noturnos por tosse e chiado 2 a 3 vezes por semana há 4 meses. Nunca foi internada, não procurou emergência no último ano e não usou corticoide oral. Prefere "o mínimo de remédio possível" e diz que se acostumou com o chiado. Não fuma, não usa betabloqueador nem anti-inflamatório. Hoje, em consulta ambulatorial agendada, está sem desconforto, FR 16 irpm, SpO2 97%, sibilos expiratórios esparsos. Espirometria: VEF1 de 58% do previsto, VEF1/CVF 0,62, com aumento de 420 mL (18%) após broncodilatador. Eosinófilos 410/mm³, IgE total 380 UI/mL. Técnica inalatória adequada, verificada na consulta. O tratamento inicial mais adequado é:

A) Budesonida-formoterol apenas quando necessário

B) Budesonida-formoterol dose baixa, manutenção e resgate

C) Budesonida-formoterol dose média, manutenção e resgate

D) Corticoide inalatório dose baixa e salbutamol no resgate

---

7 Homem de 49 anos apresenta há 6 meses aumento indolor e bilateral das glândulas lacrimais, com proptose leve à esquerda. Tem rinossinusite crônica com crostas e epistaxe ocasional, tratada com três cursos de antibiótico sem melhora. Nega asma, perda de peso ou xerostomia. PA 124 × 80 mmHg, sem linfonodomegalia, sem aumento de submandibulares ou parótidas. VHS 62 mm/h, PCR 38 mg/L, eosinófilos 600/mm³, creatinina 0,9 mg/dL, urina tipo 1 normal. IgG4 sérica de 168 mg/dL (referência: até 135). ANCA por imunofluorescência não reagente. Biópsia da glândula lacrimal: infiltrado linfoplasmocitário denso com 45 plasmócitos IgG4 positivos por campo de grande aumento e razão IgG4/IgG de 30%, com áreas de necrose geográfica, microabscessos neutrofílicos e células gigantes multinucleadas dispersas, sem flebite obliterante. O diagnóstico mais provável é:

A) Doença relacionada à IgG4

B) Granulomatose com poliangeíte

C) Sarcoidose com acometimento orbitário

D) Linfoma MALT de anexos oculares

---

8 Homem de 58 anos, hipertenso com má adesão ao tratamento e tabagista, chega à emergência 1 hora e 40 minutos após dor torácica anterior de início súbito, já máxima desde o primeiro instante, que depois passou para a região interescapular. Está sudoreico e ansioso. Recebeu AAS 300 mg na triagem. Ao exame: PA de 172 × 96 mmHg no braço direito e de 118 × 74 mmHg no esquerdo, FC 98 bpm, SatO2 96%; pulso radial esquerdo mais fraco que o direito; sopro diastólico 2+/6 na borda esternal direita; sem déficit neurológico. ECG: supradesnivelamento do segmento ST de 2 mm em DII, DIII e aVF, com infradesnivelamento em DI e aVL. Troponina I 0,9 ng/mL (referência: até 0,04). Radiografia de tórax no leito: mediastino superior de 9 cm. O serviço de hemodinâmica está disponível e pode receber o paciente em 30 minutos. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Heparina não fracionada em dose plena

B) Fibrinólise com tenecteplase

C) Angiotomografia de aorta

D) Angioplastia primária da coronária direita

---

9 Mulher de 49 anos, natural de Salvador, com paraparesia espástica progressiva há 3 anos, urgência miccional e lombalgia, teve diagnóstico de mielopatia associada ao HTLV-1, com Western blot reagente no soro e anticorpos no líquor. Nos últimos 4 meses a marcha piorou rapidamente, e o neurologista indicou pulso de metilprednisolona 1 g/dia por 3 dias seguido de prednisona oral. Nega diarreia, dor abdominal, prurido ou lesões de pele. Hemoglobina 12,8 g/dL, leucócitos 6.900/mm³ com eosinófilos 380/mm³, função renal e hepática normais. Três exames parasitológicos de fezes, pelo método de sedimentação espontânea (Hoffman), negativos. Sorologia para Strongyloides não disponível no serviço. Antes de iniciar o corticoide, a conduta mais adequada é:

A) Ivermectina empírica antes do corticoide

B) Pulso sem antiparasitário, com parasitológico de controle

C) Albendazol por 3 dias antes do corticoide

D) Contraindicar o corticoide pelo HTLV-1

---

10 Homem de 61 anos, com cirrose por hepatite C tratada com resposta virológica sustentada há 3 anos, Child-Pugh B8, é internado eletivamente para paracentese de alívio. Usa propranolol 40 mg e espironolactona 200 mg ao dia. Assintomático, sem dor abdominal, consciente e orientado, sem flapping; temperatura de 36,6 °C, PA 112/70 mmHg, FC 68 bpm. A punção diagnóstica foi difícil, exigiu três tentativas e o líquido saiu róseo e clareou no decorrer da drenagem. Líquido ascítico: leucócitos 820/mm³, 38% de polimorfonucleares (311/mm³), hemácias 48.000/mm³, proteína total 1,1 g/dL, albumina 0,6 g/dL, glicose 110 mg/dL, LDH 90 U/L; Gram sem bactérias, cultura semeada em frascos de hemocultura em andamento. Albumina sérica 2,9 g/dL, creatinina 1,0 mg/dL, bilirrubina total 2,1 mg/dL, sódio 136 mEq/L. A interpretação do líquido e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) PBE / cefotaxima isolada

B) PBE / cefotaxima e albumina

C) Peritonite secundária / tomografia de abdome

D) Sem PBE / aguardar a cultura

---

11 Homem de 57 anos, dispéptico há 6 meses, sem perda de peso, febre ou sudorese. Usa omeprazol há 2 meses, com melhora parcial. A endoscopia mostra área infiltrativa e erosada de 4 cm no corpo gástrico. A biópsia revela infiltrado de pequenas células de zona marginal com lesões linfoepiteliais, CD20 positivo, CD5, CD10 e ciclina D1 negativos, Ki-67 de 10%, sem lençóis de células grandes, e pesquisa de Helicobacter pylori positiva na histologia. A ecoendoscopia mostra infiltração até a submucosa, sem linfonodos perigástricos aumentados, e a TC de tórax, abdome e pelve é normal (estádio I). Hb 13,9 g/dL, LDH normal. A pesquisa por FISH detecta a translocação t(11;18)(q21;q21). A conduta mais adequada é:

A) Gastrectomia total com linfadenectomia

B) Imunoquimioterapia com R-CHOP

C) Erradicação do H. pylori e radioterapia gástrica

D) Erradicação do H. pylori isoladamente

---

12 Homem de 63 anos, em investigação de febre vespertina, sudorese noturna e perda de 8 kg há 3 meses, é internado por confusão e poliúria. Usa colecalciferol 7.000 UI por semana há 2 anos, prescrito por osteopenia. Esplenomegalia a 4 cm do rebordo costal; a tomografia mostra linfonodomegalias retroperitoneais de até 3 cm, sem lesões ósseas líticas. Cálcio total 13,4 mg/dL (8,5 a 10,5), albumina 3,6 g/dL, fósforo 4,3 mg/dL (2,5 a 4,5), creatinina 1,7 mg/dL, PTH 6 pg/mL (15 a 65), PTHrP indetectável, 25-hidroxivitamina D 42 ng/mL (30 a 60), 1,25-di-hidroxivitamina D 118 pg/mL (20 a 79), eletroforese de proteínas sem pico monoclonal, DHL 680 U/L. Além da hidratação venosa, o mecanismo da hipercalcemia e o tratamento específico são, respectivamente:

A) Intoxicação por vitamina D / suspender o colecalciferol

B) Calcitriol extrarrenal / glicocorticoide

C) PTHrP tumoral / bisfosfonato venoso

D) Osteólise local / denosumabe

---

13 Mulher de 33 anos, com esclerose múltipla remitente-recorrente há 6 anos, em uso de natalizumabe com índice anti-JC negativo, procura o pronto-socorro por piora da fraqueza da perna esquerda e da visão do olho direito há 24 horas, déficits que tinham sobrado de surtos em 2021 e 2023. Refere ardor miccional e polaciúria há 3 dias e calafrios. Temperatura 38,7 °C, PA 112/70 mmHg, FC 104 bpm. Exame: força grau 3 na perna esquerda (era 4 no último retorno), acuidade visual de 20/100 à direita (era 20/40), com defeito pupilar aferente relativo já conhecido, sem déficit em território novo. Urina: piócitos incontáveis e nitrito positivo. Glicemia e eletrólitos normais. RM de crânio de 2 meses atrás sem lesões novas. A conduta mais adequada é:

A) Tratar a infecção urinária e a febre

B) Metilprednisolona 1 g/dia por 3 a 5 dias

C) Plasmaférese em 5 sessões

D) Suspender natalizumabe e investigar LEMP

---

14 Mulher de 34 anos, natural de Pernambuco, procura atendimento por palpitações e cansaço aos esforços há 3 semanas. Teve febre reumática aos 10 anos e usa penicilina benzatina irregularmente. Não tem hipertensão, diabetes, doença vascular ou insuficiência cardíaca diagnosticada; não fuma e usa DIU de cobre. Ao exame: PA 116 × 72 mmHg, FC 104 bpm, ritmo irregular, B1 hiperfonética, estalido de abertura e ruflar diastólico apical. ECG: fibrilação atrial com resposta ventricular de 108 bpm. O escore CHA2DS2-VA calculado na triagem é zero. Ecocardiograma: área valvar mitral de 1,3 cm² pela planimetria, gradiente médio de 9 mmHg, átrio esquerdo de 52 mm, sem trombo visível, PSAP de 44 mmHg, FE de 62%. Creatinina 0,6 mg/dL, hemograma normal. Foi iniciado metoprolol para controle da frequência. Quanto à prevenção de tromboembolismo, a conduta mais adequada é:

A) Apixabana 5 mg de 12 em 12 horas

B) Varfarina com RNI alvo entre 2 e 3

C) Nenhuma anticoagulação, pelo escore zero

D) Dabigatrana 150 mg de 12 em 12 horas

---

15 Homem de 70 anos, hipertenso, diabético e tabagista, com creatinina basal de 1,3 mg/dL, foi submetido a cateterismo cardíaco por via femoral com angioplastia da artéria descendente anterior, recebendo 180 mL de contraste iodado, com hidratação venosa antes e depois. No segundo dia a creatinina era de 1,4 mg/dL e recebeu alta com AAS, clopidogrel e atorvastatina. Retorna no 21º dia com creatinina de 3,8 mg/dL, em ascensão progressiva desde a segunda semana segundo exames do posto, PA de 178 × 100 mmHg (antes controlada) e dor no hálux esquerdo. Ao exame, livedo reticular em coxas e pododáctilos arroxeados, com pulsos pediosos palpáveis. Eosinófilos 980/mm³, C3 72 mg/dL (90 a 180). Urina com proteína em traços, sem hemácias e sem leucocitúria. O diagnóstico mais provável é:

A) Trombose aguda da artéria renal

B) Doença renal ateroembólica

C) Nefrite intersticial aguda pelo clopidogrel

D) Lesão renal induzida por contraste

---

16 Mulher de 72 anos, com artrite reumatoide em uso de metotrexato 20 mg/semana há 3 anos e ácido fólico 5 mg/semana, tem doença renal crônica com creatinina de 1,9 mg/dL (TFGe de 26 mL/min/1,73 m²), sem ajuste recente da dose. Há 10 dias foi tratada para cistite com sulfametoxazol-trimetoprima por 7 dias, prescrito no pronto-atendimento. Há 4 dias surgiram úlceras orais dolorosas e, hoje, febre de 38,4 °C. PA 108 × 64 mmHg, FC 104 bpm, mucosite extensa, sem foco infeccioso evidente. Hb 8,9 g/dL, VCM 104 fL, leucócitos 1.100/mm³ com 300 neutrófilos, plaquetas 31.000/mm³, ALT 88 U/L. Já se suspendeu o metotrexato, colheram-se culturas e iniciou-se cefepime. A medida específica mais importante neste momento é:

A) Ácido fólico 5 mg ao dia

B) Filgrastim subcutâneo diário

C) Ácido folínico em dose alta

D) Hemodiálise convencional

---

17 Mulher de 33 anos, professora, previamente hígida, está no 5º dia de dengue confirmada por NS1 reagente no 2º dia; a febre cedeu ontem. Relata cansaço e inapetência, mas aceita bem líquidos; nega dor abdominal, vômitos, tontura ao levantar e redução da diurese. Notou pontos vermelhos nas pernas, sem sangramento de mucosas, sem melena e sem fluxo menstrual aumentado. Ao exame, PA 112/72 mmHg deitada e 110/70 mmHg em pé, FC 84 bpm, enchimento capilar de 2 segundos, petéquias nos membros inferiores, prova do laço positiva, sem hepatomegalia e sem derrames. Hematócrito 41% (basal de 39% no 2º dia), plaquetas 14.000/mm³, albumina 3,8 g/dL. A família pede que se faça transfusão de plaquetas 'antes que sangre'. A conduta mais adequada é:

A) Transfusão profilática de plaquetas

B) Internação com hidratação venosa

C) Prednisona para a plaquetopenia

D) Hidratação oral e reavaliação diária

---

18 Homem de 56 anos, ex-tabagista (20 maços-ano, parou há 10 anos), recebeu diagnóstico de TEP segmentar bilateral há 5 dias, com PA normal, ventrículo direito normal ao ecocardiograma e troponina normal; está em rivaroxabana e assintomático. Nos 3 meses anteriores não fez cirurgia, não foi internado, não ficou imobilizado, não teve trauma nem viagem longa e não usa testosterona. Peso estável, sem sangramentos, sem alteração do hábito intestinal. A mãe teve câncer de mama aos 72 anos e o irmão, câncer de pâncreas aos 68; ele pergunta se não deveria "fazer uma tomografia do corpo todo". Exame físico completo, hemograma, cálcio, enzimas hepáticas, creatinina, urina tipo 1 e radiografia de tórax normais; PSA 1,2 ng/mL; colonoscopia de 3 anos atrás normal. Não tem antecedente de sangramento e o clearance de creatinina é de 92 mL/min. A duração da anticoagulação e a investigação de câncer oculto mais adequadas são, respectivamente:

A) Prolongada sem data / investigação básica já feita

B) Três meses / investigação básica já feita

C) Prolongada sem data / TC de abdome e pelve

D) Três meses / PET-CT de corpo inteiro

---

19 Mulher de 34 anos, com vitiligo desde os 20 anos, procura atendimento por cansaço progressivo há 8 meses, perda de 6 kg, náuseas, desejo por sal e tontura ao levantar. Pele com hiperpigmentação nas pregas palmares e na gengiva. PA 92 × 60 mmHg deitada, caindo para 78 × 50 mmHg em pé, FC 104 bpm. Sódio 128 mEq/L, potássio 5,6 mEq/L, glicemia 74 mg/dL, cortisol às 8 horas 2,1 µg/dL, ACTH 410 pg/mL (até 46), anticorpo anti-21-hidroxilase positivo. TSH 8,9 mUI/L (0,4 a 4,5), T4 livre 1,0 ng/dL (0,9 a 1,8), anti-TPO negativo, ultrassonografia de tireoide normal. Cálcio, hemograma e vitamina B12 normais. A hidrocortisona e a fludrocortisona serão iniciadas hoje. Em relação ao TSH, a conduta mais adequada é:

A) Repetir o TSH após a reposição de glicocorticoide

B) Levotiroxina em dose baixa iniciada hoje

C) Levotiroxina após 48 horas de hidrocortisona

D) Cintilografia de tireoide com captação

---

20 Mulher de 71 anos, com hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade (IMC de 31 kg/m²), sem diabetes (glicemia de jejum 98 mg/dL, HbA1c 5,6%), é encaminhada ao ambulatório por esteatose hepática moderada descrita em ultrassonografia feita para investigar cálculos. Usa losartana e atorvastatina há 6 anos. Nega consumo de álcool. Assintomática; sem estigmas de hepatopatia, baço não palpável. Exames: ALT 58 U/L (referência até 33), AST 44 U/L (referência até 32), GGT 70 U/L, plaquetas 215.000/mm³, albumina 4,2 g/dL, bilirrubinas normais. HBsAg, anti-HCV e anti-HIV não reagentes; ferritina 210 ng/mL com saturação de transferrina de 28%; FAN não reagente. O FIB-4 calculado é de 1,9. Ela pergunta se a estatina lesou o fígado. A conduta mais adequada para a avaliação de fibrose é:

A) Elastografia por ressonância magnética

B) Biópsia hepática percutânea

C) Repetir o FIB-4 em 2 a 3 anos

D) Elastografia hepática transitória agora

---

21 Mulher de 74 anos, hipertensa e com osteoartrite, é encaminhada por anemia macrocítica progressiva há 1 ano, hoje dependente de 2 unidades de concentrado de hemácias por mês. Usa losartana e fez reposição de vitamina B12 intramuscular por 3 meses, prescrita pela UBS, sem resposta. Nega etilismo, sangramentos e perda de peso. Exame: palidez, sem esplenomegalia nem linfonodomegalias. Hemoglobina 7,6 g/dL, VCM 108 fL, reticulócitos 0,6%, leucócitos 4.300/mm³ com 2.100 neutrófilos, plaquetas 410.000/mm³. B12, folato, TSH, função renal e hepática normais; ferritina 860 ng/mL. Mielograma: medula normocelular com megacariócitos hipolobulados e mononucleares, displasia eritroide e 2% de blastos, sem sideroblastos em anel. Cariótipo: 46,XX,del(5q) isolada em 18 de 20 metáfases. Eritropoetina sérica de 820 mUI/mL. A filha pergunta se a mãe tem leucemia e se precisará de transplante. A categoria de risco e o tratamento mais adequado são, respectivamente:

A) Baixo risco / eritropoetina recombinante

B) Alto risco / azacitidina

C) Alto risco / transplante alogênico

D) Baixo risco / lenalidomida

---

22 Mulher de 41 anos, com asma grave, é internada na UTI com pneumonia pneumocócica e choque séptico. Recebeu 30 mL/kg de Ringer lactato nas primeiras 3 horas, ceftriaxona com azitromicina, metilprednisolona 40 mg de 6 em 6 horas e salbutamol por nebulização contínua (10 mg/hora) desde a admissão, além de noradrenalina, hoje em 0,06 mcg/kg/min e em redução. Na 6ª hora: PA 118/70 mmHg (PAM 86 mmHg), FC 128 bpm, extremidades quentes, tempo de enchimento capilar de 2 segundos, diurese de 1,2 mL/kg/h, SvcO2 76%; sibilos esparsos, sem uso de musculatura acessória. Ultrassonografia: linhas B bilaterais que não existiam na admissão. Glicemia 248 mg/dL, potássio 3,1 mEq/L. Lactato arterial de 3,8 mmol/L na admissão e de 5,9 mmol/L agora; pH 7,31, bicarbonato 17 mEq/L. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Nova expansão com 30 mL/kg de cristaloide

B) Associar dobutamina para elevar a oferta de oxigênio

C) Reduzir o salbutamol e manter a reanimação atual

D) Ampliar o antibiótico para meropeném e vancomicina

---

23 Homem de 62 anos, com diagnóstico de doença de Parkinson há 3 anos, retorna por piora. O quadro começou com lentidão e rigidez bilaterais e simétricas, sem tremor de repouso; usa levodopa/benserazida com 1.000 mg/dia de levodopa há 1 ano, sem melhora perceptível. Há 4 anos tem disfunção erétil e, há 2, urgência e incontinência urinária, atribuídas à hiperplasia prostática e tratadas com tansulosina. Refere tontura ao se levantar e duas quedas: PA 132/80 mmHg deitado e 92/60 mmHg após 3 minutos em pé, sem aumento da FC (68 para 70 bpm). A esposa relata que ele se debate durante os sonhos e tem um ruído agudo inspiratório durante a noite. Exame: bradicinesia e rigidez simétricas, voz trêmula e aguda, dismetria leve à prova índex-nariz, movimentos oculares verticais preservados, cognição normal. Na RM de encéfalo, o achado esperado é:

A) Atrofia mesencefálica com ponte preservada

B) Hiperintensidade cruciforme na ponte em T2

C) Ausência de alterações estruturais

D) Ventrículos dilatados com sulcos altos apertados

---

24 Mulher de 54 anos tem esclerose sistêmica cutânea limitada há 14 anos, com fenômeno de Raynaud, esclerodactilia, telangiectasias faciais e anticorpo anticentrômero positivo. Há 1 ano apresenta dispneia progressiva, hoje aos pequenos esforços, e teve um episódio de síncope ao subir escadas. Ao exame: PA 112 × 72 mmHg, FC 96 bpm, SatO2 93% em repouso, turgência jugular com onda v proeminente, impulsão paraesternal esquerda sustentada e edema de membros inferiores. Espirometria: CVF de 88% do previsto, com DLCO de 36%. TC de tórax de alta resolução sem doença intersticial. ECG: desvio do eixo para a direita e padrão rSR' em V1. Ecocardiograma: dilatação de átrio e ventrículo direitos, PSAP estimada em 72 mmHg, septo interatrial íntegro ao estudo com microbolhas e valvas esquerdas normais. Na ausculta, espera-se encontrar, quanto à segunda bulha e ao sopro, respectivamente:

A) Desdobramento fixo de B2 / sopro ejetivo pulmonar

B) B2 única / sopro ejetivo que diminui na inspiração

C) P2 hiperfonética / ruflar diastólico apical

D) P2 hiperfonética / sopro sistólico que aumenta na inspiração

---

25 Mulher de 26 anos, com lúpus há 2 anos (artrite, fotossensibilidade, FAN e anti-DNA reagentes), em uso de hidroxicloroquina, teve quadro gripal há 1 semana. Há 5 dias surgiram petéquias em membros inferiores, gengivorragia e epistaxe; há 2 dias, cefaleia leve e temperatura de 37,8 °C. Consciente, orientada, sem déficit focal, PA 118 × 72 mmHg, FC 92 bpm, sem esplenomegalia. Hb 12,1 g/dL, reticulócitos 1,2%, leucócitos 4.200/mm³, plaquetas 6.000/mm³. LDH 230 U/L (referência: até 250), bilirrubina indireta 0,5 mg/dL, haptoglobina normal, Coombs direto negativo. Esfregaço revisto pelo hematologista: macroplaquetas, sem esquizócitos. Creatinina 0,8 mg/dL, urina sem hematúria ou proteinúria, C3 discretamente baixo. TC de crânio sem sangramento. A conduta inicial mais adequada é:

A) Corticoide e imunoglobulina venosa

B) Plasmaférese e corticoide em dose alta

C) Transfusão de plaquetas isolada

D) Rituximabe e eltrombopague

---

26 Homem de 34 anos, agricultor no interior de Minas Gerais, há 2 semanas esvaziou um paiol de milho com muitos roedores. Há 4 dias tem febre, mialgia intensa, cefaleia e dor abdominal; há 12 horas surgiram tosse seca e dispneia progressiva. Temperatura 38,6 °C, PA 86/54 mmHg, FC 124 bpm, FR 34 irpm, SpO2 84% em ar ambiente, estertores crepitantes bilaterais, sem sufusão conjuntival e sem icterícia. Hemoglobina 18,2 g/dL, hematócrito 54% (referência: 40 a 50), leucócitos 18.000/mm³ com desvio e linfócitos atípicos, plaquetas 42.000/mm³, creatinina 1,4 mg/dL, bilirrubina total 0,8 mg/dL, CK 160 U/L, lactato 3,2 mmol/L. Radiografia: infiltrado intersticial bilateral e pequeno derrame pleural bilateral. A equipe abriu o protocolo de sepse, colheu hemoculturas e iniciou ceftriaxona; é intubado. Além do suporte ventilatório, a conduta hemodinâmica mais adequada é:

A) Volume cauteloso e noradrenalina precoce

B) Ribavirina intravenosa iniciada precocemente

C) Pulso de metilprednisolona por 3 dias

D) Cristaloide 30 mL/kg nas primeiras 3 horas

---

27 Mulher de 61 anos, diabética, em hemodiálise há 4 anos, usa carbonato de cálcio 1 g em cada refeição e calcitriol 0,5 mcg/dia, este iniciado há 18 meses, quando o PTH estava em 780 pg/mL. Queixa-se de prurido; a adesão à dieta é regular e as sessões são cumpridas. Exames atuais: cálcio 10,7 mg/dL (8,5 a 10,2), fósforo 6,8 mg/dL, fosfatase alcalina 70 U/L (normal), 25-hidroxivitamina D 34 ng/mL, PTH 110 pg/mL (referência do método 15 a 65). Kt/V de 1,4. Radiografia das mãos com calcificação das artérias digitais. A conduta mais adequada em relação ao quelante de fósforo e ao calcitriol é, respectivamente:

A) Aumentar o carbonato de cálcio / manter o calcitriol

B) Trocar por sevelâmer / associar cinacalcete

C) Manter o carbonato de cálcio / suspender o calcitriol

D) Trocar por sevelâmer / suspender o calcitriol

---

28 Homem de 82 anos, com diabetes tipo 2 há 25 anos, demência moderada (depende da filha para a medicação e o banho), doença renal crônica com TFGe de 38 mL/min/1,73 m² e duas quedas nos últimos 3 meses, uma delas de madrugada com sudorese, vem à consulta com o laudo do exame: 'diabetes bem controlado', HbA1c 6,4%. Usa metformina 500 mg duas vezes ao dia, glibenclamida 10 mg duas vezes ao dia, losartana e sinvastatina. A filha mede a glicemia capilar só pela manhã, entre 98 e 130 mg/dL. Peso estável, sem poliúria ou polidipsia. PA 128 × 72 mmHg, sem hipotensão postural. Hemoglobina 12,8 g/dL. A conduta mais adequada é:

A) Trocar por insulina basal em dose baixa

B) Trocar a glibenclamida por gliclazida

C) Suspender a glibenclamida

D) Manter o esquema atual

---

29 Homem de 63 anos teve tuberculose pleural à direita há 14 anos, tratada por 6 meses com esquema completo e alta por cura. Há 1 ano nota dispneia aos médios esforços, sem febre, sem emagrecimento e sem sudorese noturna. Nunca fez cirurgia torácica, não teve trauma e não tem diagnóstico de linfoma. Ao exame, FR 18 irpm, SpO2 95%, macicez e murmúrio abolido no terço inferior direito. Radiografia e TC: derrame direito com espessamento pleural de 8 mm e calcificações, sem massas nem linfonodomegalias. Toracocentese: líquido de aspecto leitoso, que não clareia após centrifugação. Proteína 4,8 g/dL (sérica 7,0), LDH 380 U/L (sérica 210), glicose 82 mg/dL, pH 7,36, leucócitos 1.200/mm³ (linfócitos 70%), ADA 28 U/L, triglicerídeos 128 mg/dL, colesterol 340 mg/dL, presença de cristais de colesterol à microscopia. Gram, pesquisa de BAAR, teste rápido molecular e culturas negativos; citologia oncótica negativa. O diagnóstico mais provável é:

A) Quilotórax

B) Pseudoquilotórax

C) Derrame pleural maligno

D) Tuberculose pleural reativada

---

30 Homem de 46 anos, previamente hígido, sem uso de medicamentos, procura o ambulatório por pontos vermelhos nas pernas há 10 dias. Nega epistaxe, gengivorragia, hematúria, melena e cefaleia. Há 3 meses doou sangue com hemograma normal. Não bebe álcool. Exame: PA 124 × 78 mmHg, petéquias esparsas nos tornozelos, sem equimoses, sem bolhas hemorrágicas na boca, sem linfonodomegalia, baço não palpável. Exames: Hb 14,2 g/dL, leucócitos 6.400/mm³ com diferencial normal, plaquetas 26.000/mm³ confirmadas em tubo com citrato, esfregaço com plaquetas grandes e sem esquistócitos ou células imaturas. TP, TTPa e fibrinogênio normais, função hepática e renal normais, TSH normal. O residente lembra que, num caso recente de PTI com 41.000 plaquetas sem sangramento, a conduta foi apenas observar. Quanto ao tratamento inicial e à investigação adicional, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Observação / aspirado e biópsia de medula

B) Observação / sorologias para HIV e hepatite C

C) Corticoide / aspirado e biópsia de medula

D) Corticoide / sorologias para HIV e hepatite C

---

31 Mulher de 58 anos, com artrite reumatoide soropositiva há 12 anos, teve falha a metotrexato em dose plena e a dois inibidores de TNF, e a equipe optou por iniciar rituximabe. Na triagem pré-tratamento: HBsAg não reagente, anti-HBc total reagente, anti-HBs de 46 mUI/mL, HBV-DNA indetectável, ALT 22 U/L. Anti-HCV e anti-HIV não reagentes, IGRA negativo e radiografia de tórax normal. Relata ter recebido transfusão em cirurgia aos 20 anos e nega vacinação contra hepatite B. Ultrassonografia abdominal sem sinais de hepatopatia crônica. Creatinina 0,8 mg/dL. Em relação à hepatite B, a conduta mais adequada ao iniciar o rituximabe é:

A) Vacinação contra hepatite B antes da infusão

B) Nenhuma, pelo anti-HBs protetor

C) Entecavir profilático, mantido após o término

D) HBV-DNA seriado, antiviral se positivar

---

32 Homem de 39 anos, natural do interior do Maranhão, teve febre reumática aos 12 anos e abandonou a penicilina benzatina aos 15. Há 1 ano tem dispneia aos esforços moderados e, há 2 meses, dor precordial em aperto ao subir ladeiras. Nega síncope. Ao exame: PA de 162 × 48 mmHg, FC 72 bpm, rítmico; ictus no 6º espaço intercostal, na linha axilar anterior, amplo e hiperdinâmico. Na ausculta, sopro sistólico ejetivo rude 3+/6 no foco aórtico, com frêmito, irradiado para as carótidas, e sopro diastólico aspirativo 3+/6 na borda esternal esquerda, mais audível com o paciente inclinado para a frente; B1 normal e sem estalido de abertura. ECG: sobrecarga ventricular esquerda. Radiografia: aumento da área cardíaca à custa do ventrículo esquerdo. O ecocardiograma está marcado para a semana seguinte. À palpação do pulso carotídeo, espera-se encontrar:

A) Pulso bisferiens

B) Pulso alternante

C) Pulso parvus et tardus

D) Pulso paradoxal

---

33 Mulher de 52 anos, hipertensa em uso irregular de losartana e tabagista, é trazida ao pronto-socorro 3 horas após cefaleia súbita e intensa durante esforço evacuatório, seguida de vômitos e rigidez de nuca. Está sonolenta, mas desperta ao chamado e obedece a comandos (Glasgow 14), sem déficit motor. PA 186 × 104 mmHg, FC 96 bpm. A TC de crânio mostra hemorragia subaracnóidea difusa nas cisternas da base, sem hidrocefalia, e a angiotomografia revela aneurisma sacular de 7 mm na artéria comunicante anterior. A equipe de neurocirurgia programa a embolização para a manhã seguinte, cerca de 18 horas depois. O residente lembra que, em outra paciente, internada na mesma semana no 6º dia de hemorragia subaracnóidea com afasia nova, a equipe elevou a pressão arterial com noradrenalina. Sódio 139 mEq/L, creatinina 0,8 mg/dL. Quanto ao bloqueador de canal de cálcio e ao alvo de pressão arterial até a oclusão do aneurisma, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Nimodipina venosa em bolus / PA sistólica acima de 180

B) Nimodipina oral / PA sistólica acima de 180

C) Nimodipina venosa em bolus / PA sistólica abaixo de 160

D) Nimodipina oral / PA sistólica abaixo de 160

---

34 Homem de 44 anos, com hanseníase dimorfa multibacilar (14 lesões, índice baciloscópico de 3,5 no diagnóstico), está no 4º mês de PQT-U com rifampicina, clofazimina e dapsona, com boa adesão. Há 10 dias, as lesões antigas tornaram-se eritematosas, edemaciadas e infiltradas, algumas com descamação, e surgiram dor no cotovelo direito e formigamento no 4º e 5º dedos da mão direita. Nega febre, artralgia, dor ocular e lesões novas; está preocupado que a doença esteja piorando apesar dos remédios. Temperatura 36,8 °C, PA 124/78 mmHg; nervo ulnar direito espessado e doloroso à palpação, com redução da força de abdução do 5º dedo em relação à avaliação inicial e perda de sensibilidade ao monofilamento de 2 g. Sem nódulos subcutâneos dolorosos. Hemograma e função hepática normais. Quanto à PQT e ao tratamento do quadro atual, respectivamente, a conduta mais adequada é:

A) Suspender a PQT / prednisona 1 mg/kg/dia

B) Manter a PQT / prednisona 1 mg/kg/dia

C) Manter a PQT / talidomida 100 a 400 mg/dia

D) Suspender a PQT / talidomida 100 a 400 mg/dia

---

35 Homem de 58 anos, tabagista de 30 maços-ano, IMC de 30 kg/m², com pirose há 15 anos, usa omeprazol 20 mg apenas quando tem sintomas. Fez endoscopia por pirose diária nos últimos 2 meses: epitélio colunar de Prague C4M6 e esofagite erosiva Los Angeles C sobreposta, sem lesão visível à cromoscopia digital. As biópsias pelo protocolo de Seattle mostraram metaplasia intestinal com laudo indefinido para displasia, confirmado por um segundo patologista com experiência em trato gastrointestinal. Nega disfagia, perda de peso ou anemia; Hb 14,2 g/dL. Foi encaminhado ao serviço de endoscopia intervencionista com pedido de ablação por radiofrequência, porque o médico assistente considerou que "indefinido equivale a displasia". A conduta mais adequada neste momento é:

A) Ressecção endoscópica da mucosa

B) IBP duas vezes ao dia e endoscopia em 6 meses

C) Ablação por radiofrequência do segmento

D) Endoscopia de vigilância em 3 a 5 anos

---

36 Homem de 49 anos, com doença renal crônica por nefropatia hipertensiva, TFGe de 9 mL/min/1,73 m², está em preparo para diálise, com fístula arteriovenosa confeccionada há 5 semanas, ainda não maturada. Há 4 dias tem dor torácica que piora ao deitar e melhora ao sentar; na semana anterior teve coriza, odinofagia e febre por 3 dias. PA 150 × 90 mmHg, FC 92 bpm, sem pulso paradoxal, sem turgência jugular, atrito pericárdico audível. K 5,3 mEq/L, HCO3 18 mEq/L, ureia 210 mg/dL, hemoglobina 9,8 g/dL, troponina normal. ECG com complexos de baixa amplitude, sem supradesnivelamento de ST. Ecocardiograma: derrame pericárdico moderado, sem colapso de câmaras direitas. A conduta mais adequada é:

A) Hemodiálise por cateter, com heparina mínima

B) Colchicina e ibuprofeno por duas semanas

C) Pericardiocentese guiada por ecocardiograma

D) Aguardar a maturação da fístula

---

37 Homem de 51 anos é encaminhado com o diagnóstico de síndrome de Cushing. Refere ganho de 9 kg em 2 anos, concentrado no abdome, face arredondada e hipertensão de difícil controle. Consome cerca de 10 doses de destilado por dia há 15 anos e nega uso de corticoide em qualquer via, inclusive tópico ou inalatório. PA 158 × 96 mmHg, pletora facial, abdome globoso sem estrias violáceas, sem fraqueza muscular proximal e sem equimoses, com aranhas vasculares no tórax. GGT 410 U/L, AST 128 U/L, ALT 54 U/L, VCM 104 fL. Cortisol após 1 mg de dexametasona: 4,8 µg/dL (normal até 1,8). Cortisol salivar ao final da noite: 0,42 µg/dL (até 0,15). Cortisol livre urinário: 1,8 vez o limite superior. ACTH 32 pg/mL. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Cateterismo de seios petrosos

B) Teste com 8 mg de dexametasona

C) Abstinência e repetição dos testes

D) Ressonância magnética de sela turca

---

38 Um ensaio clínico randomizado em pacientes de alto risco cardiovascular mostrou que um novo hipolipemiante reduziu a incidência de infarto em 5 anos de 20% no grupo placebo para 15% no grupo tratado, e o efeito relativo foi o mesmo em todos os subgrupos de risco. Um clínico quer aplicar o resultado a um paciente de 52 anos cujo risco de infarto em 5 anos, estimado por escore validado, é de 4%. Para esse paciente, a redução absoluta do risco e o número necessário para tratar em 5 anos são, respectivamente:

A) 1% / 100

B) 5% / 20

C) 25% / 4

D) 4% / 25

---

39 Homem de 72 anos teve síncope há 5 dias enquanto estava em pé numa fila de banco, em dia quente, após 40 minutos de espera. Não houve pródromos: a esposa conta que ele caiu de repente, sem palidez prévia, e acordou em menos de 1 minuto, orientado, com corte no supercílio. Hipertenso, usa losartana e anlodipino; nega uso de outras drogas. Ao exame: PA 136 × 82 mmHg deitado e 130 x 80 mmHg após 3 minutos em pé, FC 68 bpm, sem sopros, sem déficit neurológico. ECG: ritmo sinusal, PR de 220 ms, bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional anterossuperior, QRS de 138 ms. Holter de 24 horas sem pausas, sem bloqueio atrioventricular de segundo grau e sem arritmias ventriculares. Ecocardiograma: FE de 60%, sem valvopatia. Glicemia, eletrólitos e hemograma normais. O exame a ser feito em seguida, o mais adequado, é:

A) Estudo eletrofisiológico

B) Ressonância cardíaca com realce tardio

C) Teste de inclinação ortostática

D) Teste ergométrico

---

40 Homem de 74 anos refere há 5 semanas início abrupto de dor e rigidez matinal de 2 horas em punhos e metacarpofalangeanas, com inchaço no dorso das duas mãos. Nega dor em cinturas escapular e pélvica, febre ou perda de peso. Colonoscopia de 1 ano atrás normal, PSA de 1,2 ng/mL e TC de tórax e abdome de 2 meses atrás, feita para seguimento de nódulo pulmonar, sem lesões novas. Exame: sinovite de punhos e de segunda e terceira metacarpofalangeanas bilaterais, edema depressível no dorso das mãos com aspecto de luva de boxe, tenossinovite dos flexores. VHS 64 mm/h, PCR 52 mg/L, hemograma normal. Fator reumatoide 22 UI/mL (referência: até 14) e anti-CCP de 236 U/mL (referência: até 20). Radiografia de mãos com erosão marginal na cabeça do segundo metacarpo direito. O diagnóstico e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

A) RS3PE / prednisona isolada em dose baixa

B) RS3PE / metotrexato e corticoide ponte

C) Artrite reumatoide de início tardio / prednisona isolada em dose baixa

D) Artrite reumatoide de início tardio / metotrexato e corticoide ponte

---

41 Homem de 36 anos vive com HIV e abandonou a TARV há 2 anos; o último CD4, de 1 ano atrás, era 60 células/mm³. Há 3 semanas tem cefaleia progressiva, febre vespertina e vômitos, e há 2 dias está sonolento. Temperatura 38,2 °C, PA 128/80 mmHg, FC 96 bpm, Glasgow 14 (confuso), rigidez de nuca discreta, pupilas isocóricas e fundoscopia prejudicada por pouca colaboração. No exame motor, força preservada nos quatro membros, com desvio pronador discreto do membro superior direito e reflexos simétricos. O teste rápido de antígeno criptocócico (fluxo lateral) no soro é reagente, e a sorologia IgG para toxoplasmose também é reagente. O plantonista quer puncionar logo para medir a pressão de abertura. O próximo passo mais adequado é:

A) Anfotericina empírica sem punção lombar

B) TC de crânio antes da punção lombar

C) Tratamento empírico para toxoplasmose

D) Punção lombar imediata com manometria

---

42 Homem de 52 anos acompanhado há 10 meses por parestesias ascendentes e fraqueza distal simétrica e progressiva, hoje com marcha escarvante. A eletroneuromiografia mostrou polineuropatia desmielinizante com componente axonal, e o líquor, proteína de 138 mg/dL com 2 células/mm³; recebeu o diagnóstico de polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica e fez dois ciclos de imunoglobulina intravenosa e prednisona, sem melhora. Nos últimos meses notou escurecimento da pele, pequenas pápulas vermelho-violáceas no tronco, aumento das mamas e inchaço das pernas. Exame: PA 128 × 80 mmHg, edema 2+/4 em membros inferiores, fígado a 3 cm do rebordo, baço palpável, sem macroglossia, sem hipotensão postural. Exames: Hb 15,9 g/dL, plaquetas 640.000/mm³, creatinina 0,8 mg/dL, cálcio 9,1 mg/dL, TSH 7,8 mUI/L, testosterona baixa. Imunofixação com pequena banda IgA lambda; relação kappa/lambda das cadeias livres de 0,9. A TC de bacia mostra lesão esclerótica de 2 cm no ilíaco esquerdo. O diagnóstico mais provável é:

A) Amiloidose AL com neuropatia

B) Síndrome POEMS

C) Polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica

D) Mieloma múltiplo com neuropatia

---

43 Homem de 69 anos, hipertenso, dislipidêmico e ex-tabagista, procura o pronto-socorro 18 horas após dois episódios no mesmo dia: perda visual monocular esquerda 'como uma cortina' por 5 minutos e, horas depois, fraqueza e dormência da mão direita com dificuldade para achar palavras por 40 minutos, ambos com recuperação completa. Usa losartana e sinvastatina 20 mg. PA 158/92 mmHg, FC 78 bpm regular, exame neurológico normal. ECG em ritmo sinusal; Holter de 24 horas com extrassístoles atriais frequentes, sem fibrilação atrial. RM de encéfalo sem lesão na difusão. Doppler e angiotomografia cervical: estenose de 75% na carótida interna esquerda e de 60% na direita. Ecocardiograma transtorácico normal. Além de AAS e estatina de alta potência, a conduta mais adequada é:

A) Endarterectomia esquerda nas próximas 2 semanas

B) Dupla antiagregação por 21 dias, sem cirurgia

C) Anticoagulação oral com apixabana

D) Endarterectomia bilateral após 3 meses

---

44 Homem de 49 anos, motorista de ônibus, procura atendimento por sonolência diurna há 1 ano, com dois cochilos ao volante no último mês. A esposa relata ronco alto e pausas respiratórias durante o sono. Tem hipertensão em uso de quatro anti-hipertensivos, incluindo espironolactona, com PA de 152 × 96 mmHg; não usa sedativos nem bebe álcool. IMC 36 kg/m², circunferência cervical de 45 cm, Mallampati IV. Escala de sonolência de Epworth: 15. TSH e hemograma normais. Fez poligrafia domiciliar (tipo 3, sem eletroencefalograma) que mostrou índice de apneia e hipopneia de 4 eventos/hora, com tempo de registro válido de 3 horas e 10 minutos; ele conta que naquela noite ficou acordado boa parte do tempo, incomodado com os sensores. O médico assistente considerou a apneia afastada e pensa em narcolepsia. O próximo exame mais adequado é:

A) Teste de latências múltiplas do sono

B) CPAP com titulação automática domiciliar

C) Aparelho intraoral de avanço mandibular

D) Polissonografia completa em laboratório

---

45 Mulher de 42 anos, hipertensa há 2 anos, controlada com anlodipino 5 mg, é encaminhada por episódios de palpitação, cefaleia e sudorese, que relaciona a momentos de ansiedade. Usa há 1 ano, à noite, o comprimido que o neurologista prescreveu para profilaxia da enxaqueca e para ajudar no sono, e desde então tem boca seca e constipação. Nega uso de descongestionantes, cocaína ou anfetaminas. PA 134 × 84 mmHg, FC 88 bpm, sem hipotensão postural, sem manchas café com leite ou neurofibromas. Metanefrinas livres plasmáticas colhidas em decúbito após 30 minutos de repouso: metanefrina 0,38 nmol/L (até 0,45) e normetanefrina 1,34 nmol/L (até 0,90). Glicemia, TSH e cálcio normais. A conduta mais adequada é:

A) Fenoxibenzamina e depois imagem adrenal

B) Cintilografia com metaiodobenzilguanidina

C) Tomografia de abdome com contraste

D) Retirar a droga noturna e repetir a dosagem

---

46 Homem de 74 anos, com dislipidemia e doença arterial coronariana, usa sinvastatina 40 mg/dia há anos, AAS e losartana. Há 6 dias recebeu claritromicina na UPA por pneumonia comunitária, com melhora da febre. Desde o quarto dia de antibiótico refere dor difusa e fraqueza nas coxas, e há 2 dias nota urina escura. Hoje escorregou no banheiro e permaneceu 40 minutos no chão até ser socorrido. PA 128 × 76 mmHg, FC 88 bpm, afebril, dor à palpação das coxas, sem déficit neurológico focal nem sinais de síndrome compartimental. Exames: CK 46.000 U/L, creatinina 2,9 mg/dL (basal 1,0), K 5,4 mEq/L, cálcio 7,9 mg/dL, fósforo 6,1 mg/dL, hemoglobina 13,8 g/dL, LDH 980 U/L, haptoglobina normal. Fita urinária com sangue 3+; sedimento com 1 a 2 hemácias por campo e cilindros granulosos pigmentados. A causa da lesão renal e o fator desencadeante mais provável são, respectivamente:

A) Mioglobinúria / imobilização após a queda

B) Hemoglobinúria / hemólise pela claritromicina

C) Mioglobinúria / sinvastatina com claritromicina

D) Glomerulonefrite / pneumonia em atividade

---

47 Mulher de 42 anos, com hepatite autoimune tipo 1 diagnosticada há 3 anos (FAN 1:640, antimúsculo liso 1:160, IgG de 3.100 mg/dL e biópsia com hepatite de interface e infiltrado plasmocitário), sem cirrose na época (elastografia de 6,1 kPa). Está em uso de azatioprina 100 mg e prednisona 5 mg ao dia, com boa adesão. Assintomática, deseja engravidar no próximo ano e pede para suspender as medicações. Nos últimos 24 meses, ALT e AST estiveram normais em todas as dosagens trimestrais (última ALT de 28 U/L, referência até 33). Exames atuais: bilirrubinas normais, albumina 4,1 g/dL, INR 1,0, plaquetas 230.000/mm³, leucócitos 5.400/mm³, IgG de 1.980 mg/dL (referência de 700 a 1.600). Elastografia atual de 5,8 kPa. A conduta mais adequada é:

A) Manter azatioprina e prednisona

B) Biópsia hepática antes da retirada

C) Retirar a azatioprina gradualmente

D) Trocar azatioprina por micofenolato

---

48 Homem de 47 anos, sem doenças conhecidas e sem medicações, foi picado por uma vespa no jardim há 3 semanas. Em 10 minutos teve tontura e síncope, com PA de 64 × 30 mmHg na chegada do resgate, sem urticária, angioedema, sibilância ou sintomas gastrointestinais; recebeu adrenalina intramuscular e se recuperou em 1 hora. Antes, só havia tido reações locais a picadas. A triptase colhida 1 hora após o evento foi de 48 ng/mL; a triptase basal hoje é de 26 ng/mL (referência: até 11,4). IgE específica para veneno de Vespula de 2,1 kUA/L. Exame físico normal, sem lesões cutâneas pigmentadas e sem hepatoesplenomegalia; hemograma e função hepática normais. Já recebeu prescrição de adrenalina autoinjetável. Em relação à imunoterapia com veneno e à investigação adicional, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Não indicada / pesquisa de mastocitose clonal

B) Indicada / sem investigação adicional

C) Não indicada / sem investigação adicional

D) Indicada / pesquisa de mastocitose clonal

---

49 Mulher de 36 anos, em uso de anticoncepcional oral combinado, fez artroscopia de joelho direito há 3 semanas. Há 2 dias tem dor pleurítica à direita e dispneia leve. Sem câncer, sem doença cardíaca ou pulmonar crônica, sem sangramento prévio. Ao exame: PA 124 × 78 mmHg, FC 92 bpm, FR 18 irpm, SatO2 96% em ar ambiente, temperatura 36,8 °C; panturrilha direita discretamente empastada. D-dímero de 3.200 ng/mL. Angiotomografia: falhas de enchimento em artérias lobares inferiores e em ramos segmentares dos dois pulmões, com relação VD/VE de 0,8 e sem refluxo de contraste para a veia cava inferior. Troponina I e BNP normais. Creatinina 0,7 mg/dL, plaquetas 248.000/mm³. Mora com o marido a 15 minutos do hospital e tem acesso garantido ao retorno. A dor cede com dipirona. A conduta mais adequada é:

A) Trombólise sistêmica com alteplase

B) Alta precoce com rivaroxabana

C) Internação com heparina não fracionada

D) Internação com enoxaparina e ecocardiograma

---

50 Homem de 56 anos, com diabetes tipo 2 em uso de insulina (HbA1c de 9,8%), sorologia para HIV não reagente, tem cefaleia e febre baixa há 3 semanas; há 4 dias surgiram diplopia e sonolência. Temperatura 37,9 °C, Glasgow 13, rigidez de nuca, paralisia do VI nervo à direita, sem outros déficits. Glicemia capilar de 260 mg/dL. TC de crânio: realce leptomeníngeo nas cisternas da base e dilatação ventricular leve, sem lesões com efeito de massa. Líquor: 280 células/mm³ com 70% de linfócitos, proteína 240 mg/dL, glicose 32 mg/dL com glicemia simultânea de 210 mg/dL, ADA 14 U/L, teste rápido molecular com Mycobacterium tuberculosis detectado, sem resistência à rifampicina. O endocrinologista pede que se evite corticoide pelo controle glicêmico difícil. Quanto ao uso de corticoide sistêmico e à duração total do tratamento antituberculose, respectivamente, a conduta mais adequada é:

A) Sem corticoide / 6 meses

B) Com corticoide / 6 meses

C) Com corticoide / 12 meses

D) Sem corticoide / 12 meses

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado R04

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1	A	B	C	D	2	A	B	C	D	3	A	B	C	D	4	A	B	C	D
5	A	B	C	D	6	A	B	C	D	7	A	B	C	D	8	A	B	C	D
9	A	B	C	D	10	A	B	C	D	11	A	B	C	D	12	A	B	C	D
13	A	B	C	D	14	A	B	C	D	15	A	B	C	D	16	A	B	C	D
17	A	B	C	D	18	A	B	C	D	19	A	B	C	D	20	A	B	C	D
21	A	B	C	D	22	A	B	C	D	23	A	B	C	D	24	A	B	C	D
25	A	B	C	D	26	A	B	C	D	27	A	B	C	D	28	A	B	C	D
29	A	B	C	D	30	A	B	C	D	31	A	B	C	D	32	A	B	C	D
33	A	B	C	D	34	A	B	C	D	35	A	B	C	D	36	A	B	C	D
37	A	B	C	D	38	A	B	C	D	39	A	B	C	D	40	A	B	C	D
41	A	B	C	D	42	A	B	C	D	43	A	B	C	D	44	A	B	C	D
45	A	B	C	D	46	A	B	C	D	47	A	B	C	D	48	A	B	C	D
49	A	B	C	D	50	A	B	C	D										